

Terapia *metakognitywna*

Klasyczne CBT pracuje z treścią myśli. MCT pracuje z relacją do myśli — z metapoznawczymi przekonaniem, które każą się myślą zajmować.

CZAS: 25 min Po klasycznej pracy z myślami **ŹRÓDŁO:** Wells (2009, MCT); Spada i wsp. (2015)

JAK UŻYWAĆ

Terapia metakognitywna (ang. *metacognitive therapy, MCT*) — podejście Adriana Wellsa (Manchester) skupia się nie na treści myśli, ale na **relacji do nich**. W MCT pracujemy z **przekonaniami metapoznawczymi** — przekonaniem o myślach: „*muszę się tym zająć*”, „*jeśli o tym pomyślę, to znaczy że tego chcę*”, „*moje myśli mnie definiują*”. Karta przedstawia: 1) różnicę między CBT a MCT, 2) **CAS** (syndrom uwagi poznawczej), 3) uważność z dystansu (ang. *detached mindfulness*) (uważna obserwacja z dystansu), 4) techniki ćwiczeniowe.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wells (2009) zauważył, że **tradycyjne CBT pracuje z TREŚCIĄ** myśli („*czy to prawda?*”), ale często to nie wystarcza: pacjent zmienia jedną myśl, pojawia się następna. **MCT pracuje z PROCESEM** — co robisz z myślą gdy się pojawi. W PPU dominują dwa metapoznawcze błędy: 1) „*muszę się tą myślą zająć*” (zamartwianie się — co prowadzi do ruminacji), 2) „*jeśli pomyślałem o porno, to znaczy że muszę*” (utożsamianie myśli z impulsem). Spada i wsp. (2015) wykazali, że **MCT-PPU** ma porównywalną skuteczność do CBT, a jest **krótsza** (8–10 sesji vs 14–16). Dla pacjentów z bardzo natrętnym myśleniem o porno — MCT może być bardziej efektywne niż klasyczne kwestionowanie myśli.

01 ✂ CBT vs MCT — różnica

CBT — PRACA Z TREŚCIĄ

Pojawia się myśl: „*Muszę obejrzeć porno*”.
CBT pyta: *czy to prawda?*
Odpowiedź: nie muszę, mogę nie obejrzeć.
Cel: **zmiana treści myśli**.

Działa dobrze przy myślach *okazjonalnych*.

MCT — PRACA Z PROCESEM

Pojawia się myśl: „*Muszę obejrzeć porno*”.
MCT pyta: *co robisz z tą myślą?*
Odpowiedź: zajmuję się nią, analizuję, walczę.
Cel: **zmiana relacji do myśli** — pozwolić jej być, nie reagować.

Działa dobrze przy myślach *uporczywych*.

02 ✕ CAS — syndrom uwagi poznawczej

Wells (2009) opisał **CAS** (*cognitive attentional syndrome*) — wzorec reakcji na natrętne myśli, który *utrzymuje* problem. Trzy elementy:

1 · RUMINACJA

Wielokrotne, intensywne myślenie o problemie. „*Dlaczego znowu o tym myślę? Co to znaczy? Co teraz?*” Walka z myślą wzmacnia ją.

2 · MONITOROWANIE ZAGROŻENIA

Skanowanie umysłu w poszukiwaniu myśli o porno. „*Czy znowu myślę o tym?*” — paradoksalnie *przywołuje* myśl.

3 · STRATEGIE KONTROLI

Tłumienie myśli, rozproszenie, racjonalizacja, walka. Każda z nich *karmi* myśl uwagą. Cel: **nie reagować**.

Zamiast CAS — uważność z dystansu (ang. *detached mindfulness*) — świadomy, ale bez reakcji. To *nie* tłumienie myśli i *nie* rozwiązywanie. To trzecia opcja: *świadoma niereaktywność*.

ĆWICZENIE CHMUR

Pojawia się myśl: „*chcę obejrzeć porno*”. Wyobraź sobie, że to chmura przepływająca po niebie. Patrzysz, jak przepływa. Nie chwytasz. Nie odpychasz. Niech przepłynie. Po 30–60 s. inna chmura — może nawet ten sam typ. To OK.

ĆWICZENIE POCIĄGU

Wyobraź, że stoisz na peronie. Każda myśl to pociąg, który podjeżdża i odjeżdża. *Nie wsiadasz*. Po prostu patrzysz. Niektóre pociągi są kuszące — i tak nie wsiadasz. Stoisz. Patrzysz. Decydujesz, że dziś nie podróżujesz.

CZY RUMINUJĘ O PORNO

— *jak często, jak długo*

CZY MONITORUJĘ MYŚLI

— „*czy znowu pomyślałem o porno?*”

JAKIE STRATEGIE KONTROLI STOSUJĘ

— *tłumienie, rozpraszanie, walka, racjonalizacja*

CO SPRÓBUJĘ ZMENIĆ

— *która strategia karmi myśl uwagę*

Kluczowa różnica: uważność z dystansu (ang. *detached mindfulness*) *nie* jest tym samym co tłumienie myśli. Tłumienie mówi: „*nie myśl o tym*” (i myśl rośnie). Uważność z dystansu mówi: „*OK, myśl jest, niech będzie, nie reaguję, nie walczę, nie analizuję*”. To trzecia opcja. Wymaga praktyki — pierwsze próby zwykle są niezgrabne. Po 4–8 tygodniach codziennego ćwiczenia pacjent zauważa: natrętne myśli stają się rzadsze, krótsze, mniej angażujące.

Klucz: Spada i wsp. (2015) w RCT n=42 wykazali, że **8-sesyjna MCT-PPU** dała 70% redukcji objawów w 3-miesięcznej obserwacji — wynik porównywalny z 14-sesyjną CBT-PPU. Mechanizm: pacjent przestaje „*walczyć*” z natrętnymi myślami, więc one tracą paliwo. Wells (2009) zwraca uwagę, że klasyczne CBT może *paradoksalnie* wzmacniać CAS — bo uczy „*pracować z każdą myślą*”. MCT uczy *nie* pracować — pozwolić myśli przepłynąć. Dla pacjentów z PPU typu „*ruminacyjnego*” (dużo myślenia, fantazji, planowania) — MCT może być szczególnie skuteczna.